

Physioguide — Clínica — Canal de Guyon vs túnel cubital

AlKinora / Physioguide es orientativo: no sustituye criterio clínico ni diagnóstico presencial. Ningún test aislado confirma diagnóstico. No se inventan sensibilidad, especificidad ni likelihood ratios. Si la evidencia es mixta o procede de una sola serie, el texto lo indica.

Status: ACTIVE (Phase 1)

Evidence: Territorio cubital, Froment, Tinel en codo vs muñeca

Principles: Master clinical document

1. DEFINITION

El nervio cubital puede comprimirse en el codo (túnel cubital / epitrocleo-olecraniano) o en la muñeca (canal de Guyon). El paciente describe anular y meñique; el error es llamar a todo “túnel carpiano”.

2. DISCRIMINACIÓN

- Túnel cubital (codo) — Guyon (muñeca)
- Empeora — Flexionar codo, apoyar codo — Manillar, presión palmar cubital, muñeca
- Tinel — Canal cubital del codo — Pisiforme / Guyon
- Dorso cubital de la mano (ramo dorsal) — A menudo afectado (ramo dorsal nace proximal a Guyon) — A menudo respetado
- Froment / Wartenberg — Posible — Posible (zonas motoras de Guyon)
- Elbow flexion test — Apoya codo — Menos relevante

Regla: hormigueo 4.º–5.º que empeora al dormir con el codo doblado !' codo primero. Ciclista con presión en palma cubital !' Guyon.

3. CLUSTER CODO (ya en neural)

Parestesias 4.º–5.º + flexión de codo + Tinel cubital ± Froment.

4. AI RULES

- Meñique solo `` STC.
- Froment = motor cubital, no localiza solo: usa historia de codo vs palma.
- Ramo dorsal cubital sensible !' más codo (o lesión proximal), no Guyon típico.
- No inventar Sn/Sp.

Citation: Novak/Mackinnon ulnar neuropathy. Anatomía del ramo dorsal cubital. Elbow flexion test (Buehler).

